

19 体位ドレナージ療法

postural drainage therapy

到達目標

- 体位ドレナージ療法を含めた気道クリアランス法 (ACT) の定義と目的を理解できる
- 体位ドレナージ療法の基本的な手技を説明できる
- 体位ドレナージ療法の適応と禁忌を説明できる
- 体位ドレナージ療法の効果を評価できる
- 体位ドレナージ療法のエビデンスに言及できる

1 定義および目的

気管支分泌物の管理は、呼吸器疾患、神経筋疾患、胸腹部の手術を受ける患者に至るまで、幅広い病状において重要な課題である。

気道クリアランスは、大きく3つの働きからなる。①肺胞領域に沈着した異物を排除する肺胞マクロファージ、②終末細気管支から気管支における異物や粘液を中枢気道に移動させる線毛運動、③中枢気道での異物などを除去する咳嗽反射の働きである¹⁾。

気道クリアランス法 (Airway Clearance Techniques (ACT)) という用語は、過剰な分泌物を排除するための方策を指す。ACTの目的は、気道内腔を占める分泌物によって引き起こされる気道閉塞を改善し、気道感染症を防ぎ、肺の虚脱領域を再拡張し、ガス交換を改善することである²⁾。ACTは、ハフィング/強制呼出手技、アクティブサイクル呼吸法、修正体位ドレナージ、振動呼気陽圧療法などが主な手法となる。急性期や増悪期には理学療法士などによる徒手的な介入が主に行われる³⁾。維持期にはACTについてセルフマネジメントできるよう指導する。

本項ではACTのひとつである体位ドレナージ療法 (postural drainage therapy 体位排痰法) について説

明する。体位ドレナージとは、各肺葉あるいは肺区域の解剖学的位置を考慮して、気道分泌物が貯留した末梢肺領域が高い位置に、中枢気道が低い位置になるような体位をとり、重力の作用によって貯留分泌物の誘導排出を図る方法である³⁾。

2 基本的な手技

各肺葉あるいは肺区域の解剖学的位置を考慮して、頭低位を含むいくつかの体位でそれぞれ3~15分程度行う。①仰臥位 (肺尖区、前上葉区、前肺底区)、②前傾側臥位 (後上葉区、外側肺底区、腹臥位の代用)、③後傾側臥位 (右中葉、左舌区)、④側臥位 (外側肺底区、一側全肺野の代用)、⑤腹臥位 (上下葉区、後肺底区) の5体位が修正された代表的な体位である (図1)。

最近では、人工呼吸療法中には体位が制限されることも、頭低位が取りにくく循環動態ストレスも生じることもあり、修正体位ドレナージが一般的に用いられるようになっている³⁾。

3 適応と禁忌

a 適 応

- 気道クリアランスが障害されている：①喀痰量 (気道分泌物) が多い (25~30 mL/day 以上)、②挿管中など
- 喀痰喀出困難例 (神経筋疾患、挿管中など)
- 粘液栓や無気肺の合併
- 体位に関連した低酸素化が生じる場合 (片側肺疾患など)

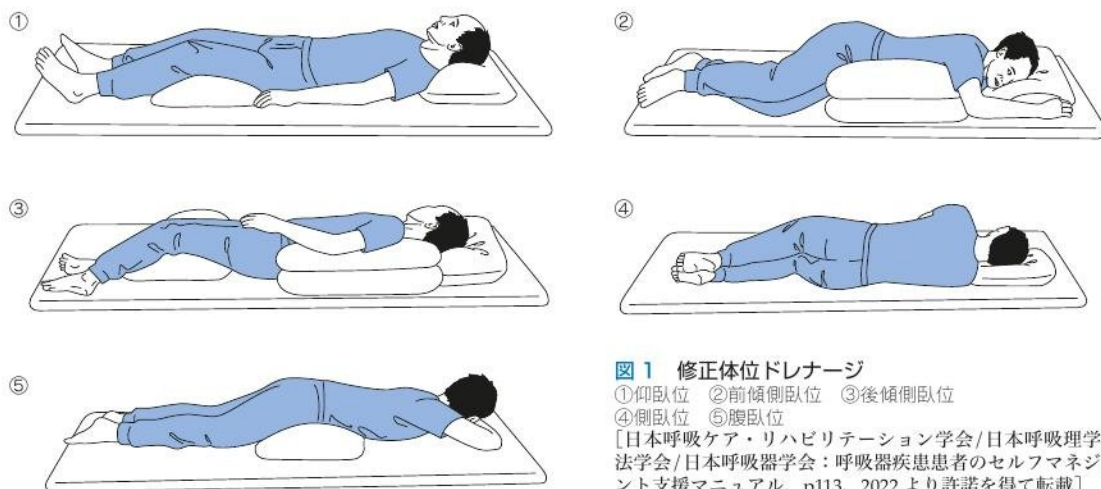


図1 修正体位ドレナージ

①仰臥位 ②前傾側臥位 ③後傾側臥位
④側臥位 ⑤腹臥位

〔日本呼吸ケア・リハビリテーション学会/日本呼吸理学療法学会/日本呼吸器学会：呼吸器疾患患者のセルフマネジメント支援マニュアル, p113, 2022より許諾を得て転載〕